



EXAMEN BLANC DE RESIDANAT

année universitaire 2025-2026

Epreuve 2 (A)
98 QCM et 18 cas cliniques
22 Octobre 2025

Cette épreuve comprend 98 QCM et 18 cas cliniques

Partie A : QCM

Veillez inscrire les réponses aux QCM dans la grille réservée aux QCM

QCM 1- Les complications de l'hypothyroïdie périphérique sont :

- A- Un épanchement péricardique
- B- Un syndrome cérébelleux
- C- Des hallucinations auditives
- D- Elargissement de la différentielle
- E- Un syndrome d'apnée du sommeil

QCM 2- Une altération de la fonction ventilatoire au cours de l'hypothyroïdie est secondaire à :

- A- Une macroglossie
- B- Une myopathie musculaire respiratoire
- C- Un renforcement de la force contractile du myocarde
- D- Un épanchement pleural
- E- Une augmentation de l'apport d'oxygène au myocarde

QCM 3- Les causes d'hypothyroïdie iatrogène sont :

- A- Le Sélénium
- B- L'Amiodarone
- C- Le thyrozol ®
- D- Le cynomel®
- E- Inhibiteurs de la tyrosine kinase

QCM 4- Le dosage de TSH à réaliser en cas suspicion d'hypothyroïdie :

- A- Doit être à jeun
- B- Doit être de première intention
- C- Doit être complété par FT3
- D- Peut être normal dans la forme centrale
- E- Est freinée dans la forme primaire

QCM 5- Les causes iatrogènes d'hyperthyroïdie sont :

- A- Les inhibiteurs de tyrosine kinase
- B- La corticothérapie
- C- Le lugol avant thyroïdectomie
- D- L'amiodarone
- E- Le lithium

QCM 6- Les facteurs déclenchants potentiels de crise aiguë thyrotoxique sont :

- A- Un Accident vasculaire cérébral
- B- La phase précoce du traitement par iode radioactif
- C- L'hémisuccinate d'hydrocortisone en IV
- D- L'instauration d'anti-thyroïdiens de synthèse
- E- L'administration de produit de contraste iodé

QCM 7- L'ophtalmopathie basedowienne :

- A- A une origine auto-immune
- B- Est sans relation avec le degré de thyrotoxicose
- C- Est en relation avec le taux des anticorps anti-récepteurs de TSH
- D- Est améliorée par les anti-thyroïdiens de synthèse
- E- Peut-être aggravée par un traitement par iode radioactif

QCM 8- L'ophtalmopathie basedowienne peut être aggravée par :

- A- Le tabac
- B- Une élévation de TSH
- C- Le sélénium
- D- La chirurgie thyroïdienne
- E- La corticothérapie en IV

QCM 9- Les causes de maladie d'Addison sont:

- A- La tuberculose
- B- Un surdosage en AVK
- C- Radiothérapie cérébrale
- D- Le traumatisme abdominal grave
- E- Les anticorps anti-21hydroxylase

QCM 10- Une insuffisance surrénalienne associée à des surrénales hypertrophiées peut être observée au cours de :

- A- La tuberculose
- B- Une mutation du gène Prop1
- C- Un cancer du sein
- D- Un bloc enzymatique en 21 hydroxylase
- E- Une Apoplexie hypophysaire récente

QCM 11- Une insuffisance surrénalienne aiguë chez un patient infecté par VIH peut être due à une atteinte surrénalienne par:

- A- La tuberculose
- B- L'hémisuccinate d'hydrocortisone
- C- Le Kétoconazole
- D- Le traitement anti-rétroviral
- E- Une localisation surrénalienne de sarcome de Kaposi

QCM 12- L'insuffisance surrénalienne aiguë au cours de la maladie d'Addison se distingue d'une IS centrale par :

- A- La pâleur
- B- La sévérité du tableau clinique
- C- L'absence de déficit en minéralocorticoïde
- D- Une tendance à l'hyperkaliémie
- E- Une ACTH freinée

QCM 13- Les causes possibles d'une insuffisance surrénale périphérique aiguë sont:

- A- Un syndrome des anticorps anti-phospholipides
- B- Une apoplexie hypophysaire
- C- Un traumatisme crânien grave
- D- Méningococcie
- E- Un surdosage aux anticoagulants

QCM 14-Le caractère malin d'une adénopathie est suspecté devant les caractéristiques suivantes :

- A-Le caractère douloureux
- B-Le caractère mal limité de l'adénopathie
- C-La consistance ferme
- D-Le caractère inflammatoire
- E-La consistance dure

QCM 15-Le bilan de 1ère intention à demander devant une adénopathie superficielle comprend

- A-TDM à la recherche d'adénopathies profondes
- B- Bilan hépatique
- C- LDH
- D- Sérologie VIH
- E- Calcémie

QCM 16-Devant des polyadénopathies, la brucellose est évoquée devant :

- A-Une fièvre prolongée hectique
- B- Un contage alimentaire
- C- Une hyperleucocytose
- D- Une lymphopénie
- E- Une éosinophilie

QCM 17-Devant des polyadénopathies, la sarcoidose est évoquée devant

- A- Une anergie à la tuberculine
- B- Une enzyme de conversion est élevée
- C- Une hypercalciurie
- D- Le caractère compressif des adénopathies
- E- Le caractère douloureux des adénopathies

QCM18- Le coma est défini comme :

- A-Une altération transitoire de la vigilance
- B- Une abolition durable de la conscience et de la vigilance
- C- Un état réversible par la stimulation douloureuse
- D- Un Glasgow inférieur ou égal à 15
- E-Une abolition de la conscience associée à une absence d'éveil spontané ou provoqué

QCM 19- Un patient comateux présente des pupilles intermédiaires aréactives, une paralysie de la verticalité du regard et un Babinski bilatéral. Où se situe la lésion ?

- A- Cortex frontal bilatéral
- B- Mésencéphale
- C- Protubérance
- D- Bulbe
- E- Diencephale

QCM 20- Un myosis punctiforme bilatéral évoque :

- A- Une atteinte protubérantielle
- B- Une atteinte mésencéphalique
- C- Une atteinte diencephalique
- D- Une intoxication opiacée
- E- Une encéphalopathie post-anoxique

QCM 21- La dyslipidémie la moins fréquente est la dyslipidémie

- A- de type II a hétérozygote
- B- secondaire
- C- de type I
- D- de type IV
- E- de type IIb

QCM 22- Dans la plaque vasculaire, les LDL sont plus atherogènes s'ils sont :

- A- estérifiés
- B- oxydés
- C- de grande taille
- D- de densité élevée
- E- reconnus par leur LDL récepteur

QCM 23- Les triglycérides en excès se déposent dans:

- A- le foie
- B- les paupières
- C- le pancréas
- D- la rate
- E- les parois vasculaires

QCM 24- L'exploration d'une anomalie lipidique comporte :

- A- le dosage des triglycérides
- B- le calcul du LDL-cholestérol
- C- le dosage du HDL-cholestérol
- D- le calcul du non HDL-cholestérol
- E- le dosage du cholestérol total

QCM 25-Parmi les critères définissant le syndrome métabolique on retient l'élévation :

- A- de la glycémie
- B- du HDL-cholestérol
- C- du LDL-cholestérol
- D- de la pression artérielle
- E- de l'IMC (Indice du Masse Corporelle)

QCM 26-Le risque vasculaire est élevé en cas d' excès de:

- A- chylomicrons
- B- LDL
- C- HDL
- D- IDL
- E- VLDL

QCM 27-Une hyperlipoprotéïnémie peut être secondaire à:

- A- une stéatose hépatique
- B- un éthylisme chronique
- C- une insuffisance surrénalienne
- D- un syndrome de cushing
- E- un syndrome néphrotique

QCM 28-Les critères hémodynamiques typiques d'un état de choc cardiogénique sont :

- A. Index cardiaque $< 2,2 \text{ L/min/m}^2$
- B. Pression Artérielle Pulmonaire d'Occlusion (PAPO) $> 15 \text{ mmHg}$
- C. Lactatémie $> 2 \text{ mmol/L}$
- D. Pression artérielle diastolique $< 40 \text{ mmHg}$
- E. pression veineuse centrale $< 2 \text{ mmHg}$

QCM 29-La contractilité myocardique :

- A. Dépend de l'état des protéines contractiles
- B. Dépend des récepteurs bêta-adrénergiques
- C. Est indépendante de l'oxygénation myocardique
- D. Diminue lors d'une acidose
- E. Est majorée par le parasympathique

QCM 30-Le traitement étiologique du choc cardiogénique comporte :

- A. le drainage péricardique en cas de tamponnade
- B. la chirurgie cardiaque en cas de thrombose de prothèse valvulaire
- C. un traitement anti-arythmique en cas de trouble du rythme sévère
- D. une greffe cardiaque immédiate en cas de myocardite fulminante

E. un antidote par bicarbonate molaire IV en cas d'une intoxication par les tricycliques

QCM 31- Le risque infectieux après une fracture ouverte de jambe est plus important en cas de :

- A- Délabrement important des parties molles
- B- Diabète déséquilibré
- C- Ouverture cutanée Cauchoix I
- D- Mécanisme par écrasement
- E- Traitement chirurgical par plaque vissée

QCM 32- Le diagnostic de pseudarthrose septique de la jambe repose sur :

- A- Mobilité du foyer de fracture
- B- Douleurs à la mise en charge
- C- Condensation des berges fracturaires
- D- Présence d'une fistule
- E- Déficit des releveurs du pied

QCM 33- La prise en charge thérapeutique d'une fracture de jambe type III selon la classification de Cauchoix, est :

- A- Une amputation en cas d'atteinte artérielle réparable
- B- Un enclouage centromédullaire
- C- Une fixation externe
- D- Une ostéosynthèse par plaque vissée
- E- Une couverture de la perte de substance par un lambeau en urgence si l'os est exposé

QCM 34- Après traitement d'une fracture de jambe, lors de la première phase de rééducation :

- A- L'appui total est non autorisé au patient
- B- A pour objectif la récupération des amplitudes articulaires
- C- Le renforcement musculaire à l'aide d'appareil est autorisé
- D- A pour durée quinze jours
- C- L'utilisation de canne est obligatoire

QCM 35- Parmi les conditions suivantes, celles qui peuvent cadrer avec une pseudarthrose aseptique de la jambe:

- A- le siège proximal de la fracture est un facteur favorisant
- B- l'histoire d'un écoulement purulent de la cicatrice opératoire est en faveur ce diagnostic.
- C- peut se traduire radiologiquement par une cassure du matériel d'ostéosynthèse.
- D- peut se traduire par une mobilité du foyer fracturaire.
- E- le tabagisme actif est un facteur favorisant.

QCM 36-Devant une hématurie associée à une douleur lombaire on évoque :

- A- Une lithiase rénale
- B- Une sténose de l'artère rénale
- C- Une cystite
- D- Une tumeur rénale
- E- Une glomérulonéphrite post infectieuse

QCM 37- Devant une hématurie associée à un complément sérique bas on évoque :

- A- Une glomérulonéphrite avec dépôts mésangiaux d'immunoglobuline A
- B- Une vascularite à ANCA
- C- Une cryoglobulinémie
- D- Un syndrome d'Alport
- E- Un syndrome hémolytique et urémique atypique

QCM 38- La glomérulonéphrite aiguë post infectieuse est :

- A- Fréquente chez le sujet âgé
- B- Récidivante
- C- Traitée par des antibiotiques
- D- Révélée le plus souvent par un syndrome néphritique aigu
- E- Classiquement bénigne

QCM 39- Les mécanismes suivants sont impliqués dans le développement d'une splénomégalie

- A- Hyperplasie splénique
- B- Augmentation de la pression dans le système porte
- C- Surcharge pondérale
- D- Prolifération lymphoïde
- E- Métaplasie myéloïde

QCM 40- Quelles sont les propositions exactes relatives à la technique d'examen de la rate?

- A- Est palpée sur un malade en décubitus dorsal
- B- Est palpée sur un malade en décubitus latéral droit
- C- L'examineur se place du côté gauche du malade
- D- Avec le bout des doigts sous les côtes gauches
- E- En demandant au malade de faire une apnée en inspiration profonde

QCM 41- La suspicion d'une anémie hémolytique devant une splénomégalie implique de demander :

- A- Les réticulocytes
- B- Le TP
- C- La bilirubine directe
- E- Les LDH
- D- La ferritinémie

QCM 42- Les valeurs normales de la calcémie totale en mmol/l sont :

- A- Entre 1,2 et 1,6mmol/l
- B- Entre 2,1 et 2,5 mmol/l
- C- Entre 2,2 et 2,6 mmol/l
- D- Entre 2,3 et 2,8mmol/l
- E- Entre 3,2 et 3,6mmol/l

QCM 43- La parathormone (PTH) est une hormone qui:

- A- Augmente la réabsorption urinaire du calcium
- B- Diminue l'excrétion urinaire du phosphore
- C- Stimule directement les ostéoblastes
- D- Est régulée par le taux du calcium plasmatique
- E- Augmente directement l'absorption digestive du calcium

QCM 44- Les signes fonctionnels d'une hypercalcémie peuvent être :

- A- Un syndrome sub-occlusif
- B- Des réflexes ostéo-tendineux abolis
- C- Des crampes musculaires
- D- Des douleurs osseuses
- E- Une hypertension artérielle

QCM 45- Une hypercalcémie peut être secondaire à:

- A- Une sarcoïdose
- B- Une hémochromatose
- C- Une chondrocalcinose
- D- Une maladie de Hodgkin
- E- Un myélome multiple

QCM 46- L'athyréose chez le nourrisson :

- A. entraîne un tableau grave dès la naissance
- B. est la cause la plus fréquente de dysgénésie thyroïdienne
- C. se présente avec des hormones thyroïdiennes indétectables

- D. se présente avec une TSH très élevée
- E. est responsable d'une diminution de la thyroglobuline dans le sang

QCM 47- Le retard diagnostique d'une hypothyroïdie chez le nourrisson expose à (aux) risque(s) suivants :

- A. retard mental irréversible
- B. complications cardiovasculaires
- C. avance staturale
- D. un nanisme harmonieux
- E. obésité contrastant avec un retard statural

QCM 48- Les dysgénésies thyroïdiennes incluent :

- A. les anomalies du développement thyroïdien
- B. les mutations inactivatrices des récepteurs thyroïdiens
- C. l'absence totale du tissu thyroïdien
- D. les défauts de migration de l'ébauche thyroïdienne
- E. les hypoplasies thyroïdiennes

QCM 49 : Les signes cliniques suivants font évoquer un ictère à bilirubine conjuguée chez l'enfant:

- A- Urines foncées
- B- Erythrosepalmiaire
- C- Sellesdécolorées
- D- Prurit
- E- Angiomestellaire

QCM 50 : Dans l'atrésie des voies biliaires :

- A- les selles sont normocolorées
- B- l'ictère est à bilirubine conjuguée
- C- les ASAT et les ALAT sont élevées
- D- les GGT sont normales
- E- les voies biliaires intra-hépatiques sont dilatées à l'échographie

QCM 51-La syphilis secondaire :

- A-Survient dans 50% des cas après une syphilis primaire non traitée
- B- Se caractérise par des lésions vésiculeuses touchant les paumes et les plantes
- C- La première floraison survient dans les 6 semaines suivant le chancre
- D- Les lésions cutanées sont toujours contagieuses
- E- Se caractérise sur le plan sérologique par un TPHA - et VDRL +

QCM 52-Le gonocoque :

- A- Est un germe strictement intracellulaire
- B- Se transmet de la mère à l'enfant au cours de l'accouchement

- C- Se manifeste par des ulcérations génitales chez la femme et une urétrite aigue chez l'homme
- D- Peut être responsable d'une atteinte anorectale asymptomatique
- E- Les fluoroquinolones représentent le traitement de choix

QCM 53-L'infection à herpès simplex virus (HSV) :

- A-Est un co- facteur important de l'infection par le VIH
- B- Se caractérise par une primo-infection symptomatique dans 90 % des cas
- C- Elle survient au début de l'activité sexuelle
- D- Le diagnostic repose essentiellement sur la sérologie
- E- La latence est cliniquement silencieuse et s'effectue dans les ganglions nerveux sensitifs

QCM 54-La variabilité génétique du VIH :

- A-Est à l'origine de la résistance du virus au traitement antirétroviral
- B- Est due aux erreurs commises par l'intégrase lors de l'intégration de l'ADN
- C- Est due à la forte réplication du virus du VIH
- D- Représente un obstacle au développement du vaccin contre le VIH
- E- Est à l'origine d'une transmission plus faible du virus chez l'Homme

QCM 55-Les infections opportunistes les plus fréquentes chez le sujet infecté par le VIH sont :

- A-La cryptococcose neuroméningée
- B- La toxoplasmose cérébrale
- C- La pneumocystose pulmonaire
- D- La leucoencéphalite multifocale progressive
- E- La leishmaniose viscérale

QCM 56-Au cours d'une Insuffisance Rénale Aiguë fonctionnelle, quelle(s) anomalie(s) biologique(s) retrouve(nt)-t-on habituellement ?

- A-Na⁺ urinaire (natriurèse) > 100 mmol/L
- B- Une Fraction d'Excrétion du sodium < 1 %
- C- Un rapport Na⁺/K⁺ urinaire < 1
- D- Rapport Urée urinaire/Urée plasmatique > 10
- E- Une Fraction d'Excrétion de l'Urée > 70 %

QCM 57- Au cours d'une insuffisance rénale dans quelles circonstances peut on trouver [Urée] plasmatique élevée:

- A-En cas de rhabdomyolyse
- B- En cas de traitement par corticoïdes
- C- En cas de saignement digestif
- D- En cas d'hyponatrémie
- E- IRA fonctionnelle

QCM 58-L'insuffisance rénale aiguë (IRA) secondaire aux anti-inflammatoires non stéroïdiens peut être due à :

- A- Une insuffisance rénale aigue hémodynamique
- B- Une nécrose tubulaire aiguë
- C- Une insuffisance rénale aigue obstructive
- D- Des lésions glomérulaires minimales
- E- Une néphrite interstitielle aiguë immuno-allergique

QCM 59-La corticothérapie est indiquée au cours des insuffisances rénales aiguës organiques secondaires à

- A- Une glomérulonéphrite aigue post infectieuse
- B- Une néphropathie interstitielle aigue immuno-allergique
- C- Une vascularite à ANCA
- D- Une néphropathie lupique
- E- Une nécrose tubulaire aigue

QCM 60- les principales caractéristiques du syndrome malin des neuroleptiques sont:

- A- Hyperthermie
- B- Rigidité musculaire
- C- CPK élevées
- D- Myosis serré bilatéral
- E- Troubles de la conscience

QCM 61- concernant le traitement antidotique des intoxications aux benzodiazépines, le flumazénil est :

- A. Un antagoniste compétitif des récepteurs GABA-Aergique
- B. Indiqué en cas de coma benzodiazépine isolé
- C. Indiqué en cas d'intoxication mixte antidépresseurs tricycliques + benzodiazépines
- D. Susceptible de déclencher des convulsions
- E. Administré par voie orale

QCM 62-Quels signes appartiennent au syndrome nicotinique ?

- A- Fasciculations musculaires
- B- Mydriase
- C- Crampes et paralysie musculaire
- D- Hypotension artérielle
- E- Tachycardie

QCM 63- Quelles sont les complications possibles d'une intoxication aux organophosphorés ?

- A- Œdème pulmonaire lésionnel
- B- Syndrome intermédiaire (paralysie retardée)
- C- Pancréatite aiguë

- D. Neuropathie périphérique retardée
- E. Syndrome pyramidal

QCM 64- Quels mécanismes expliquent la toxicité du CO ?

- A-Affinité du CO pour Hb 200–250 fois supérieure à celle de l'O₂
- B- Formation de carboxyhémoglobine
- C- Augmente la libération d'O₂ aux tissus
- D. Fixation sur myoglobine et cytochromes
- E. Provoque une hypoxie histotoxique

QCM 65- Les paramètres mesurés dans les urines de 24 heures pour le bilan lithiasique de 1ère intention sont :

- A. Créatinine
- B. Calcium
- C. Urée
- D. pH urinaire
- E. Acide urique

QCM 66- Concernant les lithiases oxalocalciques, laquelle/lesquelles des propositions est(sont) vraie(s) ? :

- A. Elles sont les plus fréquentes, représentant environ 70% des calculs urinaires.
- B. Elles sont toujours radio-transparentes
- C. Elles incluent le type Whewellite (monohydraté) et Weddellite (dihydraté)
- D. Elles sont liées à une hyperuricosurie.
- E. Leur densité au scanner est généralement faible (< 500 UH).

QCM 67- Parmi les lithiases urinaires suivantes, lesquelles sont radiotransparentes à l'imagerie ?

- A. Phosphates ammoniaco-magnésiens
- B. Lithiases uriques
- C. Phosphates de calcium
- D. Lithiases xanthiques
- E. Oxalate de calcium

QCM 68- Parmi les caractéristiques de l'atteinte articulaire de la polyarthrite rhumatoïde, on retient :

- A. Atteinte bilatérale et symétrique des petites articulations.
- B. Atteinte non érosive.
- C. Atteinte déformante.
- D. Atteinte migratrice.
- E. Atteinte exclusive des petites articulations.

QCM 69- Concernant l'épidémiologie de la polyarthrite rhumatoïde, quelle (s) affirmation (s) est (sont) juste (s) ?

- A. C'est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent.
- B. Elle débute habituellement entre 40 et 60 ans.
- C. Elle ne peut pas survenir chez l'homme.
- D. Des formes juvéniles peuvent apparaître avant 16 ans.
- E. Elle ne s'observe pas après 65 ans.

QCM 70-Concernant la réaction immunitaire dans la PR, quelle (s) affirmation (s)est (sont) juste (s) ?

- A. Les lymphocytes Th17 produisent l'interféron gamma.
- B. L'activation des lymphocytes T CD4+ se fait via les cellules présentatrices d'antigène exprimant HLA-DR4/DR1.
- C. L'IL-17 est produite par les lymphocytes Th17.
- D. Le rôle des lymphocytes B est négligeable.
- E. Les lymphocytes Th1 produisent l'interleukine 2 (IL-2) et l'interféron gamma.

QCM 71-Concernant le facteur rhumatoïde, quelle(s) affirmation(s)est (sont) exacte(s) ?

- A. C'est une immunoglobuline de classe IgG dirigée contre des IgM.
- B. Le test de Waaler-Rose repose sur l'agglutination de globules rouges de mouton sensibilisés par un sérum de lapin anti-globules rouges de mouton.
- C. Le test au latex utilise des particules de polystyrène recouvertes d'IgG humaines.
- D. Les tests modernes comme la néphélométrie et l'ELISA ont remplacé le test de Waaler-Rose et au Latex dans la pratique courante.
- E. Le test de Waaler-Rose est plus sensible et plus spécifique que la néphélométrie et l'ELISA.

QCM 72-Quelles sont les anomalies qu'on peut rencontrer sur les radiographies d'une main rhumatoïde :

- A-Déminéralisation en bandes.
- B- Calcification du ligament triangulaire du carpe.
- C- Erosions et géodes osseuses.
- D- Ostéophytes des interphalangiennes distales.
- E- Carpite fusionnante.

QCM 73-Concernant les échelles unidimensionnelles :

- A-Sont des échelles globales.
- B- Comportent l'échelle visuelle analogue (EVA), l'échelle numérique (EN) et l'échelle verbale simple (EVS).
- C- Sont utilisables quel que soit l'âge.
- D- Sont simples.
- E- Permettent d'évaluer la réponse au traitement antalgique.

QCM 74-L'échelle numérique

- A-Est une échelle multidimensionnelle.
- B- Est une échelle unidimensionnelle.
- C- Sa valeur varie de 0 à 10.

- D- Utilise une réglette.
- E- Une valeur maximale signifie pas de douleur.

QCM 75-Choisissez les antalgiques de niveau 2 :

- A-Dérivés salicylés.
- B- Néfopam.
- C- Codéine.
- D- Fentanyl.
- E- Propofol.

QCM 76-L'antidote de la morphine :

- A-Kétamine.
- B- Anexate.
- C- Protamine.
- D- Naloxone.
- E- N-acétylcystéine.

QCM 77-Le purpura vasculaire est :

- A- Diffus
- B- Nécrotique
- C- Extensif
- D- Palpable
- E- Associé à un syndrome hémorragique

QCM 78-Quelles sont parmi les propositions suivantes les critères de gravité d'un purpura

- A-Sa survenue chez un patient sous sintrom
- B- Son aspect en carte géographique
- C- La présence d'une oligoanurie associée
- D- La présence d'une fièvre
- E- Thrombopénie < 50 000

QCM 79-La thrombopénie immunologique primaire

- A-Est le diagnostic le plus fréquent chez la femme jeune
- B- Impose en pratique la recherche des anticorps anti-plaquettes
- C- Est caractérisé par une moelle riche à la ponction sternale
- D- Nécessite les immunoglobulines en traitement de 1ère ligne
- E- Est souvent associée à une bi ou pancytopénie

QCM 80- le purpura rhumatoïde

- A- Est caractérisé par un purpura diffus
- B- Est caractérisé par une vascularite avec dépôt d'IgA
- C- Peut se compliquer de néphropathie glomérulaire
- D- Est très fréquent chez le sujet âgé
- E- Donne des lésions cutanées qui peuvent évoluer par poussées

QCM 81-Le pouvoir tampon d'une solution est d'autant plus grand que:

- A. Le pKa est proche du pH du milieu
- B. Le stock du tampon est important
- C. Le pKa est faible
- D. Le stock acide est important
- E. Le trouble acide base est ancien

QCM 82-Le système tampon bicarbonate-acide carbonique :

- A- a une masse constante
- B-est efficace en cas d'alcalose
- C-est peu efficace en cas d'acidose
- D- est soumis à un double contrôle viscéral
- E-a une activité importante dans les compartiments intracellulaires

QCM 83-Les chémorécepteurs périphériques :

- A. ont une action lente
- B. sont insensibles aux CO₂
- C. sont sensibles à la PO₂
- D. sont stimulés par les ions H⁺
- E. inhibent les muscles ventilatoires

QCM 84-Le rein intervient dans l'équilibre acido-basique :

- A. au bout de quelques secondes
- B. en éliminant une urine de pH variable
- C. en sécrétant les acides fixes
- D. en sécrétant les acides volatils
- E. en excréant l'ammonium

QCM 85-L'excrétion tubulaire de l'ammonium est favorisée par :

- A. l'acidose
- B. l'alcalose
- C. la déplétion en potassium
- D. l'aldostérone
- E. le traitement par des corticoïdes

QCM 86-Les éléments suivants sont en faveur d'une sécrétion inappropriée d'ADH:

- A/Une osmolalité urinaire > 100mOsm / kg
- B/Une concentration de sodium urinaire ≥ 40 mmol / l
- C/ Un volume de liquide extracellulaire diminué
- D/Une hyperuricémie
- E/Une hypoosmolalité plasmatique

QCM 87- Les causes suivantes peuvent être responsables d'une sécrétion inappropriée d'ADH

- A/Une tumeur cérébrale
- B/Un hématome sous dural
- C/Un traitement par Carbamazépine
- D/Un traitement par le lithium
- E/Une tuberculose pulmonaire

QCM 88- Dans lesquelles des situations suivantes peut-on observer une hyponatrémie hypertonique?

- A. Hypertriglycéridémie sévère
- B. myélome multiple
- C. Diurèse osmotique
- D. Hyperglycémie majeure
- E. Intoxication au méthanol

QCM 89- Les étiologies de diabète insipide néphrogénique

- A/Hypokaliémie
- B/Hypercalcémie
- C/Intoxication par le lithium
- D/Tumeur hypothalamo-hypophysaire
- E/Hypocalcémie

QCM 90- Une hypokaliémie de transfert est secondaire à :

- A- Un traitement par insuline semi lente
- B- La prise de caféine
- C- Unethyrotoxicose
- D- La prise de bêta bloqueurs
- E- La prise de théophylline

QCM 91- Devant une hypokaliémie associée à une alcalose métabolique on évoque :

- A- Des diarrhées
- B- Un hyperaldostérionisme primaire
- C- La prise de diurétique thiazidiques
- D- La prise d'acétazolamide (Diamox*)
- E- La prise du Modamide

QCM 92- Une hyperkaliémie associée à une hypocalcémie peut être observée en cas de :

- A- Un syndrome de lyse tumoral
- B- Une rhabdomyolyse
- C- Une insuffisance surrénalienne aiguë
- D- Une insuffisance rénale chronique stade 5
- E- Un myélome multiple

QCM 93- Une hyperkaliémie peut être secondaire à la prise de :

- A-Bactrim*
- B- Héparine

- C- Corticoïdes
- D- Piroxicam
- E- Salbutamol

QCM 94- Les éléments suivants influencent directement l'immunogénicité d'un vaccin :

- A. La nature chimique de l'antigène vaccinal
- B. L'ajout d'un adjuvant
- C. La voie d'administration
- D. L'âge gestationnel du nourrisson à la naissance
- E. L'intervalle entre les doses

QCM 95 - Les adjuvants des vaccins :

- A. sont systématiquement utilisés avec les vaccins vivants atténués
- B. augmentent la réponse immunitaire vis-à-vis de l'antigène
- C. sont souvent des sels d'aluminium
- D. favorisent la libération prolongée de l'antigène
- E. peuvent réduire le nombre de doses nécessaires à l'immunisation

QCM 96- Les manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI) :

- A. peuvent survenir même sans lien prouvé avec le vaccin
- B. sont graves et nécessitent l'arrêt du schéma vaccinal
- C. peuvent se présenter comme des états fébriles bénins
- D. peuvent être liées à une erreur de manipulation du vaccin
- E. sont souvent inévitables

QCM 97 - A propos des effets secondaires suivants du vaccin anticoquelucheux entier :

- A. Le syndrome du cri persistant est une réaction rare mais bien décrite
- B. Une fièvre dans les 48 heures est une réaction courante
- C. L'état de choc post-vaccinal est une urgence exceptionnelle et bénigne
- D. Une encéphalopathie après vaccination impose l'arrêt de cette valence
- E. Les effets indésirables graves justifient l'arrêt de toute dose vaccinale future

QCM 98– Les vaccins qui doivent être administrés au 2ème mois de vie selon le calendrier vaccinal tunisien sont :

- A. 1ère dose du vaccin anti-hépatite B combiné à d'autres vaccins
- B. 1ère dose de vaccin anti-pneumococcique conjugué
- C. 1ère dose de vaccin anti-polio oral
- D. 1ère dose du vaccin pentavalent
- E. 1ère dose du vaccin anti-polio injectable

I- Partie II : CCQCM

Cette partie comprend cas cliniques. Les réponses doivent être inscrites sur la grille réservée aux CCQCM

Cas clinique QCM 1

Mr A.Z âgé de 70 ans, ramené aux urgences par sa famille pour asthénie, vertiges, myalgies. Il a comme antécédents : une hypercholestérolémie traitée par statine (atorvastatine 10mg/j), un diabète de type 2 sous glimépiride 2mg, des troubles du rythme cardiaque sous Amiodarone, un syndrome dépressif sous anti-dépresseurs, une anémie traitée par Fer avec Gastrite à HP sous IPP. A l'examen : la peau est infiltrée, jaunâtre, sèche, froide, la pilosité est raréfiée, oedème palpébral, apyrétique, TA= 11/6 cmHg, rythme régulier FC: 60 batt/min, eupnéique, thyroïde non palpable, les ROT diminués, discrets oedèmes des membres inférieurs bilatéraux
ECG: Rythme régulier Sinusal, Fréquence cardiaque à 60, microvoltage, troubles de la repolarisation.

QCM1- Le diagnostic d'hypothyroïdie est suspecté devant :

- A- Le syndrome dépressif
- B- La somnolence
- C- Les myalgies
- D- L'anémie par carence martiale
- E- Le microvoltage à l'ECG

QCM2- Une exploration biologique doit être demandée à la recherche de:

- A- Une hypernatrémie
- B- Une anémie avec microcytose
- C- Une hypokaliémie avec kaliurèse augmentée
- D- Des CPK élevées
- E- Une tendance à l'hypoglycémie

Le bilan a montré: TSH = 60 mUI/l, FT4 = 5 pmol/l, CPK= 1000UI, Hb= 9 g/l, Na+= 140mmol/l, K+= 4 mmol/l, Glycémie à jeun = 3,8 mmol/l, créatinémie = 150µmol/l, LDL-Cholestérol= 1,6g/l.

QCM3- La conduite à tenir immédiate est de :

- A- Augmenter la dose de statine
- B- Rechercher une insuffisance coronaire
- C- L-thyroxine 100 µg en IV
- D- Arrêter le glimépiride
- E- Réhydratation en IV

Cas clinique QCM 2

Une patiente âgée de 42 ans, sans antécédents pathologiques notables, vous consulte pour une fièvre évoluant depuis 3 jours, asthénie, et des lésions d'érythème noueux depuis 1 jour. Elle rapporte par ailleurs une toux sèche d'apparition récente. A l'examen, la température était de 38°C, la TA 120/80 mmHg, la palpation du cou trouve des adénopathies cervicales bilatérales fermes et indolores.

QCM 4-Devant ce tableau, les diagnostics possibles sont les suivants :

- A- Tuberculose
- B- Sarcoidose
- C- Syphilis
- D- Brucellose
- E- Leucémie lymphoïde chronique

QCM 5- Une radiographie du thorax faite chez cette patiente montre des opacités hilaires bilatérales, vous évoquez

- A- Tuberculose
- B- Sarcoidose
- C- Syphilis
- D- Brucellose
- E- Leucémie lymphoïde chronique

QCM 6- Parmi les propositions suivantes quels examens complémentaires vous demandez

- A- Sérologie wright
- B- Immunophénotypage lymphocytaire
- C- Frottis sanguin
- D- IDR
- E- TDM thoracique

Cas clinique QCM 3

Patient âgé de 50 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, consulte pour syndrome anémique évoluant depuis 15 jours.

L'examen clinique note une pâleur cutanéomuqueuse, un ictère conjonctival et une splénomégalie à 3 cm du rebord costal. Le reste de l'examen est normal.

Hémogramme : GB: 6700/mm³, PNN 65%, Lym 30%

Hb: 8,5 g/dl (VGM:88), GR: 3.000.000/mm³, Rétic 6%

Plaquettes: 324.000/mm³.

QCM7 -Quels sont les examens à demander dans le cadre de l'exploration de cette anémie ?

- A. Myélogramme
- B. Electrophorèse des protéines plasmatiques (EPP)
- C. Bilirubine libre
- D. LDH
- E. Haptoglobine

En plus du bilan biologique que vous avez demandé, on a complété par :

Frottis sanguin : sans anomalies
Test de Coombs Direct (TCD) : positif à Ig G

QCM 8-Quel est le diagnostic que vous avez retenu ?

- A. Anémie Hémolytique Auto Immune (AHAI)
- B. Anémie Hémolytique Allo Immune
- C. Anémie Hémolytique immuno allergique
- D. Anémie Hémolytique d'origine corpusculaire
- E. Anémie Hémolytique d'origine mécanique

QCM 9-Quel est le bilan biologique à visée étiologique à demander dans le cadre de l'exploration de cette anémie?

- A. AAN
- B. Electrophorèse des protéines plasmatiques (EPP)
- C. Scanner thoraco-abdomino pelvien
- D. Biopsie ostéo médullaire
- E. Sérologies de l'Hépatite B et C

QCM 10-Quel traitement proposez-vous ?

- A. Immunoglobulines par voie IV
- B. Transfusion par 2 culots globulaires
- C. Splénectomie
- D. Prednisone (Cortancyl®) : 1 à 2 mg/kg/j pendant 3 semaines puis une dégression sur 3 semaines
- E. Prednisone (Cortancyl®) : 1 à 2 mg/kg/j pendant 3 semaines puis une dégression sur 3 à 4 mois

Cas clinique QCM 4

Monsieur M, âgé de 55 ans, aux antécédents de diabète et de goutte, consulte aux urgences pour une impotence fonctionnelle du genou droit. A l'anamnèse, vous apprenez que les symptômes évoluent depuis dix jours. Il a pris de l'amoxicilline de son propre chef pendant 3 jours. Le patient vous signale aussi qu'il a eu il y a 15 jours une injection de corticoïdes au niveau de ce même genou pour une gonarthrose débutante. L'examen aux urgences trouve : une température à 37.6°C, une impossibilité de marcher, un genou droit globalement tuméfié chaud à la palpation. La moindre mobilisation passive est extrêmement douloureuse. Vous suspectez une arthrite septique du genou.

QCM 11- Quel(s) élément(s) peut(vent) expliquer l'absence de fièvre chez ce patient :

- A. L'injection de corticoïdes dans le genou
- B. L'antécédent de goutte
- C. Le diabète
- D. L'automédication par amoxicilline
- E. Il s'agit d'une forme débutante

QCM 12- Les 2 diagnostics différentiels à évoquer chez ce patient sont :

- A. Une poussée de gonarthrose
- B. Une poussée polyarthrite rhumatoïde
- C. Une crise de goutte
- D. Une lombosciatique tronquée
- E. Une arthropathie diabétique

Vous trouvez effectivement un épanchement du genou et vous décidez alors de réaliser une ponction du liquide articulaire afin de confirmer le diagnostic d'arthrite septique. Les résultats de l'analyse du liquide ponctionné sont les suivants :

-aspect : 60ml de liquide trouble

-examen direct à la coloration de Gram : présence de cocci gram positif en chainettes

-examen cytologique : leucocytes= 45000 avec 100% de type polynucléaires altérés, hématies =0, absence de microcristaux

-examen biochimique : Glucose 1.2mmol/l, Protides=98g/l

QCM 13- Quelle(s) est (sont) l'(les) affirmation(s) exacte(s) :

- A. Le taux de glucose est élevé
- B. Le taux de protides est élevé
- C. L'aspect trouble confirme le diagnostic d'arthrite septique
- D. Le caractère altéré des polynucléaires est en faveur du diagnostic d'arthrite septique
- E. La présence de cocci gram positif confirme le diagnostic d'arthrite septique

QCM 14- Le diagnostic d'arthrite septique du genou est retenu. Quelle bactérie est-elle le plus probablement responsable de cette arthrite septique ?

- A. Streptococcus pneumoniae
- B. Escherichia coli
- C. Staphylococcus aureus
- D. Neisseria gonorrhoeae
- E. Mycobacterium tuberculosis

Cas clinique QCM 5

Une patiente âgée de 32 ans, sans antécédent cardiovasculaire connu, est admise aux urgences pour dyspnée rapidement progressive, palpitations et malaise depuis 48h, survenus après un épisode fébrile 5 jours plus tôt.

À l'examen : TA = 82/50 mmHg, FC = 132 bpm, SpO₂ = 89 % sous 4 L/min d'O₂, Marbrures cutanées, extrémités froides, Turgescence jugulaire, crépitations bilatérales aux bases, Diurèse < 0,3 ml/kg/h.

ECG : tachycardie sinusale avec troubles de repolarisation diffus

Biologie : Troponine très élevée, lactate = 5 mmol/L, NT-proBNP = 14200 pg/ml

Échocardiographie : ventricule gauche dilaté, hypokinétique global, FEVG = 20 %, pas de valvulopathie significative

Vous retenez le diagnostic d'une myocardite aigue fulminante.

QCM 15- Les éléments de ce cas en faveur d'un état de choc cardiogénique sont :

- A. Hypotension artérielle persistante
- B. Oligurie < 0,5 ml/kg/h
- C. Fièvre initiale
- D. Marbrures et extrémités froides
- E. FEVG > basse

QCM 16. La (les) examens complémentaires de confirmation diagnostique est (sont)

- A. IRM cardiaque
- B. Biopsie endomyocardique
- C. Coronarographie
- D. Dosage de la TSH
- E. sérologie virales

QCM 17 .Le traitement de cette patiente comporte :

- A. Oxygénothérapie avec objectif SpO₂ > 94 %
- B. Dobutamine
- C. Remplissage vasculaire
- D. Anticoagulation curative
- E. des diurétiques

QCM 18. Si la patiente reste instable malgré traitement optimal, les stratégies à envisager sont :

- A. ECMO veino-artérielle
- B. Assistance circulatoire par cœur artificiel
- C. Antibiothérapie probabiliste large spectre
- D. Contre-pulsion intra-aortique systématique
- E. Association de l'adrénaline

Cas clinique QCM 6 :

Patient âgé de 54 ans, sans antécédents pathologiques notables, piéton ayant été heurté par une voiture, est emmené aux urgences pour un traumatisme ouvert de la jambe droite.

L'examen trouve une déformation de la jambe droite avec une plaie déchiquetée et contuse faisant 10 centimètres. Le pouls est présent et l'examen neurologique est sans anomalies.

La radiographie de la jambe montre une fracture comminutive du tiers moyen des deux os de la jambe.

QCM 19-Quels sont les gestes que vous devez pratiquer aux urgences ?

- A. Un parage économique de la plaie
- B. Administration d'antibiotiques par voie orale
- C. Vaccination antitétanique
- D. Lavage de la plaie et pansement stérile
- E. Administration de la première dose d'énoxaparine

Après le parage, la plaie ne peut pas être suturée et il persiste une perte de substance cutanée de 3*7 centimètres.

QCM 20- Le traitement de cette fracture peut se faire moyennant :

- A. Un enclouage centromédullaire
- B. Une traction trans-condylienne
- C. Une plaque vissée
- D. Un fixateur externe
- E. Une attelle cruro-pédieuse jusqu'à la cicatrisation cutanée

QCM 21-La prise en charge de la perte de substance cutanée consiste à :

- A. Un lambeau de couverture d'emblée si l'os est exposé
- B. Une greffe de peau mince d'emblée
- C. Une amputation vu le caractère comminutif de la fracture
- D. La cicatrisation dirigée peut être une alternative si l'os n'est pas exposé
- E. La couverture par un lambeau n'est autorisée qu'après la consolidation osseuse

QCM 22-Ce patient est exposé aux complications tardives suivantes :

- A. Infection précoce
- B. Ostéite chronique
- C. Pseudarthrose septique
- D. Syndrome de loges
- E. Embolie pulmonaire

Cas clinique QCM 7

Un homme de 45 ans victime d'un accident de la voie publique, présente une fracture spiroïde des deux os de la jambe ouverte type II de Cauchoix.

QCM 23-Une fracture ouverte de jambe Cauchoix II comporte :

- A. une perte de substance cutanée dont la suture est impossible
- B. une plaie suturable facilement sans tension
- C. doit être suturer aux urgences pour prévenir le risque infectieux
- D. une lésion cutanée à risque de nécrose secondaire
- E. une plaie à berge contuse

QCM 24-La prise en charge initiale en urgence de ce patient consiste à :

- A. deux voies d'abord périphérique et vérification des constantes hémodynamiques
- B. la sérothérapie anti tétanique est administrée selon le profil vaccinal du patient.
- C. parage et lavage de la plaie
- D. pansement stérile.
- E. une antibiothérapie synergique par voie générale à large spectre.

L'examen effectué aux urgences relève une impossibilité de la flexion dorsale du pied et des orteils.

QCM 25-La complication immédiate suspectée en premier lieu devant ces constatations cliniques est :

- A. le syndrome des loges
- B. la lésion du nerf sciatique poplitée externe
- C. la thrombophlébite
- D. l'atteinte de l'artère tibiale postérieure
- E. la section du tendon du muscle tibial antérieur

QCM 26-Les éléments de mauvais pronostic chez ce patient sont :

- A. l'âge jeune
- B. la fracture comminutive
- C. le trait spiroïde
- D. l'ouverture cutanée type II de Cauchoix
- E. l'atteinte simultanée des deux os de la jambe

Cas clinique QCM 8

Une patiente âgée de 35 ans sans antécédents pathologiques personnels et familiaux notables présente une insuffisance rénale découverte devant une hématurie macroscopique installée depuis 03 jours. La patiente se plaignait de polyarthralgies depuis 1 an. Elle rapporte un épisode d'angine qui remonte à 02 mois.

Examen clinique : PA : 160/90 mmHg, œdème au niveau des deux membres inférieurs bilatéral, symétrique et garde le godet, bandelettes urinaires : Protéine : ++, Hématurie : +++

Biologie : créatinine sérique : 150 $\mu\text{mol/l}$, protidémie : 70g/l, albuminémie : 40g/l, protéinurie : 2g/24h, CRP : 40mg/l, ECU : H : 600/mm³, L : 3/mm³, culture négative.

QCM 27- L'hématurie présentée par la patiente est d'origine glomérulaire devant les arguments suivants :

- A. Son caractère macroscopique
- B. La présence d'une pression artérielle : 160/90 mmHg
- C. Son association à une protéinurie à 2g/24h
- D. Les antécédents de polyarthralgies
- E. Son association à une insuffisance rénale

QCM 28- Les examens complémentaires à demander chez cette patiente pour étayer le diagnostic étiologique de cette hématurie sont :

- A. Dosage des fractions C3 et C4 du complément sérique
- B. Recherche des anticorps anti nucléaires
- C. Uroscanner
- D. Cystoscopie
- E. Biopsie rénale

QCM 29- Les étiologies possibles de l'hématurie chez cette patiente sont :

- A. Une GNA post infectieuse
- B. Un syndrome de Good Pasture
- C. Une néphropathie lupique
- D. Une Vascularite à ANCA
- E. Une cryoglobulinémie

Cas clinique QCM 9

Un patient âgé de 25 ans consulte pour fièvre et splénomégalie

QCM 30- Les éléments à rechercher à l'interrogatoire sont

- A. Durée d'évolution
- B. Mode d'installation de la fièvre
- C. Notion de prise de paracétamol
- D. Notion de consommation d'alcool
- E. Notion de consommation de lait non pasteurisé

Le patient vous informe que la fièvre a débuté depuis 4 jours, 7 jours après son retour d'un voyage au Cameroun

QCM 31-Le premier diagnostic à évoquer à ce stade est

- A. Paludisme
- B. Rickettsiose
- C. Brucellose
- D. Infection CMV
- E. Endocardite infectieuse

Les examens microbiologiques effectués ont permis d'éliminer ce diagnostic

QCM 32-A ce stade quels examens complémentaires demandez vous

- A. Radio thorax
- B. Sérologie CMV
- C. Sérologie Wright
- D. Anticorps antinucléaire
- E. Hémoculture

Les examens demandés sont revenus négatifs. Par ailleurs le patient est en bon état général, sa CRP : 5mg/L. les GB : 3200/mm³ avec présence de lymphocytes activés au frottis sanguin.

QCM 33-Vous retenez le diagnostic de

- A. Infection CMV
- B. Rickettsiose
- C. Brucellose
- D. Tuberculose
- E. Endocardite infectieuse

Cas clinique QCM 10

Une femme de 62 ans consulte pour asthénie, constipation et douleurs osseuses diffuses depuis plusieurs semaines.

À l'examen : TA = 135/80 mmHg, FC = 92/min, sécheresse des muqueuses, sensibilité osseuse diffuse.

Examens complémentaires :

- Calcémie totale : 3,2 mmol/L
- Albumine : 38g/L
- Phosphorémie : 0,6 mmol/L
- Créatinine : 120 µmol/L

- PTH intacte : 180 pg/mL
- Électrophorèse des protéines sériques : pas de pic monoclonal
- Radiographie du rachis lombaire : lésions ostéolytiques diffuses

QCM 34- les anomalies biologiques mises en évidence chez ce patient sont

- A. Hypercalcémie
- B. Hypophosphorémie
- C. Insuffisance rénale
- D. Hyperparathormonémie
- E. Hypoalbuminémie

QCM 35- la/(les) étiologie(s) plus probable(s) devant ce tableau est /sont:

- A. Hyperparathyroïdie primitive
- B. Hypercalcémie paranéoplasique (sécrétion de PTHrP)
- C. Myélome multiple
- D. Sarcoïdose
- E. Hypercalcémie iatrogène (vitamine D, thiazidiques)

QCM 36- les mesures thérapeutiques initiales à instaurer en urgence :

- A. Perfusion de sérum physiologique abondant (réhydratation)
- B. Bisphosphonates IV
- C. Restriction hydrique stricte
- D. Corticothérapie systématique d'emblée
- E. Administration de calcitonine pour son effet prolongé

Cas clinique QCM 11

Un nouveau-né âgé de 15 jours est ramené par ses parents aux urgences pédiatriques pour ictère cutanéomuqueux constaté depuis J5 de vie. A l'interrogatoire, les urines sont foncées et les selles décolorées.

QCM 37- Les diagnostics à évoquer devant cet ictère sont :

- A- Tumeur de la tête du pancréas
- B- Syndrome d'Alagille
- C- Atrésie des voies biliaires
- D- Déficit en alpha 1 antitrypsine
- E- Maladie de Wilson

QCM 38- L'examen d'imagerie, de première intention, que vous demandez sera:

- A- Abdomen sans préparation
- B- Echographie abdominale
- C- Echographie cardiaque
- D- Cholangiographie transhépatique

E- Radiographie de thorax

QCM 39- Le bilan sanguin montre ces anomalies:

- A- Hyperbilirubinémie à prédominance libre
- B- Hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée
- C- ASAT et des ALAT élevées
- D- Taux de prothrombine bas
- E- Phosphatases alcalines basses

Cas clinique 12

Monsieur XY vient vous consulter à la suite de la découverte d'une sérologie VIH positive lors d'un don de sang. Il avoue une toxicomanie par voie intraveineuse depuis plusieurs années.

QCM 40- Pour confirmer l'infection par le VIH vous demandez les examens suivants :

- A. Western blot
- B. ELISA 4^{ème} génération
- C. PCR VIH
- D. Taux de CD4
- E. Antigénémie P24

QCM 41- Le bilan initial à réaliser chez ce patient après la confirmation du diagnostic comprend :

- A. Une sérologie syphilis
- B. Une sérologie toxoplasmose
- C. Un taux de CD4
- D. Bilan lipidique, hépatique et rénal
- E. Une sérologie du virus HSV et gonocoque

Le bilan a été réalisé et vous avez prescrit une trithérapie chez ce patient avec un RDV de contrôle à 1 mois. Le patient était perdu de vue. Une année plus tard il consulte les urgences pour une altération de l'état général accompagnée de fièvre et diarrhées, le taux de CD4 est à 100/mm³.

QCM 42- Les diagnostics à évoquer chez ce patient sont :

- A. Une cryptosporidiose
- B. Une colite à CMV
- C. Une salmonellose
- D. Une leishmaniose viscérale
- E. Un sarcome de kaposi

Une endoscopie digestive a été réalisée et a montré une muqueuse colique inflammatoire et ulcérée avec la biopsie des cellules à inclusions virales intranucléaires en œil de hibou

QCM 43- Le diagnostic à retenir chez ce patient est

- A. Une cryptosporidiose
- B. Une colite à CMV
- C. Une salmonellose
- D. Une leishmaniose viscérale
- E. Un sarcome de kaposi

Cas clinique QCM 13

Une patiente âgée de 35 ans consulte pour oligurie

L'examen Clinique de la patiente a permis de retrouver une PA: 150/90 mmHg et des Œdèmes des membres inférieurs

A la bandelette urinaire: Hématies ++ P+++

Résultats des examens complémentaires :

- ECBU: H: 200/mm³, L: 2/mm³, culture: négative
- Protéinurie de 24heures: 2g/24h
- Créatinine plasmatique: 180 µmol/l (créatine habituelle à 80 µmol/L)
- NFS: Hb: 10g/dl, GB: 9000/mm³, plaquettes: 200000/mm³

Echographie rénale :2 reins de taille normale bien différenciés sans obstacle.

Il s'agit d'une insuffisance rénale aigüe.

QCM 44-A ce stade on peut évoquer les diagnostics suivants :

- A- Une néphropathie interstitielle aigüe
- B- Une néphropathie vasculaire aigüe
- C- Une néphropathie glomérulaire aigüe
- D- Une nécrose tubulaire aigüe
- E- Une insuffisance rénale aigüe fonctionnelle

QCM 45-Les arguments en faveur de l'origine de l'insuffisance rénale sont son association à :

- A- L'oligurie
- B- Les données de la bandelette urinaire
- C- Une anémie
- D- La pression artérielle à 150 /90 mmHg
- E- Des œdèmes des membres inférieurs

QCM 46-L'évolution était marquée par une aggravation des chiffres de créatinine passant à 250 puis à 500 µmol/L en quelques jours. L'étiologie peut correspondre alors à ;

- A- Une vascularite à ANCA
- B- Une néphropathie interstitielle aigüe immuno-allergique
- C- Une amylose rénale
- D- Une hyalinose segmentaire et focale
- E- Une néphropathie lupique classe IV

QCM 47-Quels examens indispensables pour le diagnostic étiologique de cette insuffisance rénale aigue :

- A- Un angioscanner des artères rénales
- B- Une biopsie des glandes salivaires accessoires
- C- Une ponction biopsie rénale
- D- La recherche d'une éosinophilurie
- E- Un dosage des ANCA

Cas clinique QCM 14

Patiente âgée de 25 ans aux antécédents de rhumatisme articulaire aigu présente de façon brutale depuis deux jours des lésions purpuriques au niveau des membres inférieurs, des douleurs articulaires et une diminution de la diurèse. A l'examen clinique : température : 38°, PA : 170/90 mmHg, œdème des membres inférieurs et du visage. Bandelettes urinaires : Protéinurie : ++ et hématurie : +++. Biologie : créatinine sérique : 200µmol/l, NFS : GB : 2500/mm³, HB : 8g/dl, plaquettes : 100000/mm³, protéinurie : 2,5g/24h albuminémie : 38g/l, protidémie : 70g/l, et complément sérique bas.

QCM 48- L'hématurie présentée par la patiente est d'origine glomérulaire car elle est associée à :

- A- Une protéinurie
- B- Des œdèmes des membres inférieurs
- C- Une hypertension artérielle
- D- Une oligurie
- E- Une insuffisance rénale

QCM 49- Les causes possibles de l'hématurie chez cette patiente sont :

- A- Une endocardite infectieuse
- B- Une néphropathie lupique
- C- Une vascularite à ANCA
- D- Un purpura rhumatoïde
- E- Une thrombose des veines rénales

QCM 50- Les examens complémentaires nécessaires chez cette patiente sont :

- A- Un scanner thoraco-abdomino-pelvien
- B- Des hémocultures
- C- La recherche des anticorps anti nucléaires
- D- La recherche des anticorps anti-cytoplasme des PNN
- E- Une échographie doppler des veines rénales

QCM 51- Une ponction biopsie rénale est indiquée chez patiente car l'hématurie s'associe à :

- A- Une protéinurie à 2,5g/24h
- B- Une pancytopénie

- C- Des lésions purpuriques
- D- Une fièvre
- E- Des œdèmes des membres inférieurs

Cas clinique QCM 15

Vous recevez aux urgences une patiente âgée de 20, sans antécédents, qui consulte pour une éruption cutanée. Il s'agit de lésions purpuriques diffuses, non infiltrées et non nécrotiques évoluant depuis 1 jour. Elle rapporte qu'elle a présenté ce matin une épistaxis bilatérale qui a cédé spontanément. A l'examen elle était apyrétique, avec des bulles hémorragiques endobuccales. Le reste de l'examen était sans particularités. Une NFS demandé a montré :

Hb= 10g/dl - VGM= 72fl- PLT= 2000- GB= 5600

Son score hémorragique était de 11

QCM 52-Concernant les critères de gravité de ce purpura vous retenez :

- A- L'âge
- B- Le caractère diffus
- C- Le taux d'hémoglobine
- D- Le score hémorragique
- E- Le taux des plaquettes

QCM 53-Le diagnostic de thrombopénie immunologique primaire est retenu chez cette patiente, votre conduite thérapeutique immédiate est la suivante

- A- Corticothérapie à 1mg/kg/j
- B- Immunoglobulines polyvalentes
- C- Association immunoglobulines polyvalentes avec corticothérapie à 1mg/kg/j
- D- Splenectomie
- E- Rituximab

QCM 54-Le mécanisme physiopathologique du purpura dans ce contexte est

- A- Une thrombopénie périphérique par excès de destruction
- B- Une thrombopénie centrale
- C- Une thrombopénie périphérique par excès de consommation
- D- Une thrombopénie périphérique par anomalies de la répartition
- E- Une thrombopénie périphérique par hémodilution

Cas clinique QCM 16

Patient âgé de 70 ans qui consulte pour syndrome anémique évoluant depuis 2 mois.

A l'examen on a objectivé des multiples adénopathies bilatérales et symétriques sous mandibulaires, sus claviculaires et axillaires (3 à 4 cm) avec une splénomégalie à 6cm du rebord costal.

NFS: GB=115 000 (Lymphocytes: 70%), HB=8,2 g/dl (VGM : 85, TCMH: 25),
Réticulocyte : 80 000 PLQ=90 G/L

Frottis sanguin : Petites lymphocytes matures monomorphes, avec présence d'ombres de Gumprecht.

Le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique (LLC) a été confirmé.

QCM 55. Quel est l'examen qui a permis de confirmer ce diagnostic ?

- A- Myélogramme
- B- Biopsie ostéo-médullaire
- C- Biopsie ganglionnaire
- D- Immunophénotypage lymphocytaire
- E- Cytoponction ganglionnaire

QCM 56. Le diagnostic de LLC est confirmé lorsque le score de Matutes est à :

- A- 5
- B- 4
- C- 3
- D- 2
- E- 1

QCM 57- Quel est le stade de la maladie selon la classification de Binet ?

- A- Stade A
- B- Stade B
- C- Stade C
- D- Stade D
- E- Stade E

QCM 58- Que proposez-vous pour ce patient ?

- A- Abstention thérapeutique
- B- Surveillance clinique et biologique à la consultation
- C- Traitement à base d'immuno-chimiothérapie
- D- Traitement à base d'immunothérapie seul
- E- Traitement à base de corticothérapie seul

Cas clinique QCM 17

Le jeune AH , piéton âgé de 23 ans, s'est fait renverser par une moto « Forza » occasionnant un traumatisme crânien. A l'arrivée de l'équipe de SMUR, le patient était inconscient : n'ouvrait pas les yeux à la stimulation douloureuse, émettait des sons incompréhensibles avec

réaction de retrait à la douleur. Pupilles en anisocorie. Sa PA= 100/62mmHg FC=98B/min et SpO2= 97% à l'AA.

QCM 59-quelle est la valeur du score de Glasgow chez ce patient ?

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. 7
- E. 8

QCM 60-quelle CAT à initier chez ce patient ?

- A. Induction anesthésique
- B. Intubation orotrachéale
- C. HTA thérapie
- D. Osmothérapie
- E. Hypercapnie permissive

A l'arrivée à l'hôpital, un scanner cérébral et du rachis cervical ont montré l'aspect suivant :



QCM 61. les anomalies à décrire sont :

- A. Hématome sous dural aiguë
- B. Hématome extradural
- C. Effacement des sillons sous corticaux
- D. Déviation de la ligne médiane
- E. Fracture occipitale

QCM 62. l'anomalie décrite sur le scanner:

- A. Est secondaire à un Saignement artériel entre la dure-mère et l'os
- B. Est secondaire à une rupture veineuse lentement progressive.
- C. Nécessite un traitement chirurgical

- D. Entraîne une augmentation de la pression intracrânienne selon la loi de Monroe-Kellie
- E. Est sans gravité clinique

Après les mesures thérapeutiques prises, une neuro-réanimation est poursuivie. Le bilan trouve : Hb=7.4 plq=78000 TP=74% Na+=143 paCO₂=32 mmHg gly=2.5mmol/l

QCM 63. les ACSOS sur ce bilan :

- A. Sont au nombre de 3
- B. L'hypocapnie est nécessaire pour diminuer la PIC
- C. Le seuil de plaquettes est 50000
- D. La glycémie n'est pas une ACSOS
- E. Il faut transfuser le patient pour un objectif d'Hb à 9-10g/dl

Cas clinique QCM 18

Une patiente âgée de 75 ans suivie pour une insuffisance cardiaque traitée par furosémide, digitaline et beta bloqueurs et pour une ostéoporose traitée par calcium et vitamine D présente pour une asthénie, une faiblesse musculaire, des palpitations et une constipation installée depuis une semaine. A l'examen clinique : PA : 100/50 mmHg, pli cutané persistant, auscultation cardio-pulmonaire normale et un tympanisme abdominal. Biologie : créatinine sérique : 50µmol/l, natrémie : 135mmol/l, Kaliémie : 2,4mmol/l, chlorémie : 85mmol/l, GDS artériel : PH : 7,50, bicarbonatémie : 30mmol/l.

QCM 64. Les critères de gravité de l'hypokaliémie chez cette patiente sont :

- A. L'antécédent d'une insuffisance cardiaque
- B. La prise de digitaline
- C. La présence d'une alcalose métabolique
- D. La kaliémie à 2,4 mmol/l
- E. L'âge à 75 ans

QCM 65- Les signes électrocardiographiques à rechercher chez cette patiente sont :

- F. Une arythmie par fibrillation auriculaire
- G. Des extra systoles supra ventriculaires
- H. La disparition de l'onde P
- I. L'onde U
- J. Le sous décalage du segment PQ

QCM 66- Les causes possibles de l'hypokaliémie chez cette patiente sont :

- K. Prise du furosémide
- L. Des vomissements
- M. Intoxication aux digitaliques
- N. Prise de bêta bloqueur
- O. La prise de calcium au long cours

QCM 67-Les examens complémentaires de première intention à demander à la recherche d'une étiologie de l'hypokaliémie chez cette patiente sont :

- A. Kaliurèse de 24 heures
- B. Aldostéronémie
- C. Activité rénine plasmatique
- D. Chlore urinaire
- E. Echographie doppler des artères rénales

